

CEFALEIA



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

RESUMO

- **Introdução:**

A cefaleia está entre as queixas médicas **mais comuns** na prática clínica. É definida como **dor** que acomete o **segmento cefálico**, em qualquer região. Estima-se que 98% das mulheres e 95% dos homens sofrerão algum episódio de cefaleia durante a vida.

- **Epidemiologia:**

Estudos brasileiros apontam a cefaleia como **principal causa para busca de atendimentos de urgência**; a prevalência anual da migrânea é estimada em 15,8% no Brasil, acometendo 22% das mulheres e 9% dos homens.



RESUMO

- **Etiologia:**

Primária x Secundária.

- **Fisiopatologia:**

Migrânea (disfunção nociceptiva do complexo trigeminal).

Trigêmino-autonômicas (literatura cita disfunções hipotalâmicas em sua gênese).

Secundárias (acometimento de estruturas extra e intracranianas).



ROTINA CLÍNICA

RESUMO

- **Cefaleias primárias:**

Tensional: cefaleia de **leve a moderada** intensidade, **bilateral ou holocraniana**, **NÃO pulsátil**, sem outros sintomas associados. Não costuma piorar com esforços e, geralmente, não limita as atividades usuais dos pacientes (não é incapacitante).

Migrânea: dor **unilateral**, **pulsátil**, de **moderada a forte** intensidade, associada à foto e/ou fonofobia, náuseas e/ou vômitos e com piora ao esforço. A duração é, tipicamente, de 4 a 72 horas (crises mais prolongadas são chamadas de estado migranoso).



RESUMO

- **Cefaleias primárias:**

Trigêmico-autonômicas: cefaleia de **forte intensidade, unilateral, acometendo a região periorbitária e temporal**, acompanhada de **sintomas autonômicos ipsilaterais** (hiperemia conjuntival, lacrimejamento e ptose, congestão nasal unilateral e rubor facial). É evidenciada agitação ou inquietação durante a crise álgica e a duração de cada episódio varia entre 15 a 180 minutos.



ROTINA CLÍNICA

RESUMO

- **Cefaleias secundárias:**

Hemorragia subaracnoidea (HSA): cefaleia súbita e de forte intensidade.

Thunderclap headache: a dor atinge intensidade máxima em **< 1 minuto** do início. A principal causa é a ruptura de aneurismas cerebrais (saculares).

Dissecção arterial: carotídea (dor cervical, retro-orbitária e frontal); vertebral (dor cervical posterior, com irradiação para região occipital e temporal; história de trauma, manipulação quiroprática).



RESUMO

- **Cefaleias secundárias:**

Trombose venosa cerebral: condição potencialmente grave que em até 89% dos pacientes se manifesta tendo a cefaleia como o principal sintoma, o qual, por vezes, pode ser o único.

A dor pode se instalar de forma gradual e progressiva, ou de forma súbita em Thunderclap. Pode se apresentar como o fenótipo da enxaqueca (incluindo fotofobia e fonofobia, náuseas e vômitos) e até como crise convulsiva.

Lembre-se também da **síndrome da vasoconstrição cerebral reversível** e da **hipertensão intracraniana (HIC)** como possíveis etiologias.



RESUMO

- **Cefaleias primárias:**

Benignas e com padrão típico e estereotipado dos sintomas.

Sem indicação de internação (em geral).

Não é necessário solicitar exames complementares.

- **Cefaleias secundárias:**

Malignas e com padrão variável de dor (lembrar do padrão em Thunderclap).

Com indicação de internação hospitalar (alguns casos em leito de UTI).

Sempre solicitar exames complementares!



ABORDAGEM

1º) **Caracterização** da cefaleia e estabelecimento do **diagnóstico etiológico**.
Obs. Avaliar se há presença de **sinais verdes** (possível cefaleia primária).

2º) Existem **sinais de alarme** na minha história clínica?

3º) **Exame físico:** Avaliar sinais vitais e realizar avaliação neurológica sumária.

4º) **Solicitar exame de imagem?**

A necessidade é determinada pela presença de sinais de alarme!

Qual? TC de crânio sem contraste.

Demais detalhes do tratamento estão apresentados nos modelos de prescrição.



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Cefaleia – Medicina de Emergência USP 17ª Edição.
- Evaluation of headache in adults- UpToDate.
- Emergency evaluation of the adult with new nontraumatic headache - UpToDate.
- Overview ofthunderclapheadache - UpToDate.

